

Formulación inicial del proyecto

Problema

En los puntos de dispensación, los pacientes, incluidos personas con tratamientos crónicos y adultos mayores, pueden esperar horas para recibir su fórmula. Buena parte de esa espera ocurre porque las validaciones esenciales (afiliación, vigencia y validez de la fórmula, cobertura PBS, autorización e inventario) se ejecutan hasta que el paciente ya está en ventanilla, en sistemas separados: la plataforma de cada EPS, el software de auditoría del dispensador y el inventario del punto. Al no poder conocer esos resultados antes, el paciente descubre en la fila fórmulas con errores, autorizaciones pendientes o medicamentos agotados. Debe regresar otro día, y el punto de dispensación atiende casos que no puede completar.

Objetivo general

Diseñar y desarrollar un prototipo funcional de pre-dispensación farmacéutica que permita al paciente conocer, antes de desplazarse, la validez preliminar de su solicitud y la disponibilidad de sus medicamentos, y agendar una entrega con el medicamento reservado. El propósito es reducir el tiempo de espera y los desplazamientos innecesarios, valorado frente a una línea base del proceso presencial y con sistemas externos simulados.

Objetivos específicos

- Caracterizar el proceso actual de dispensación (actores, validaciones, datos y excepciones) y establecer una línea base de tiempos y causas de espera o rechazo.
- Definir y verificar reglas de prevalidación de fórmula, afiliación, cobertura y autorización que anticipen novedades antes del desplazamiento, sin sustituir la validación oficial.
- Implementar un módulo de inventario por punto de entrega y reserva temporal de medicamentos.
- Lograr que el paciente sólo reciba una cita cuando su medicamento esté disponible y reservado, sin comprometer más existencias de las disponibles. Tener en cuenta la capacidad del punto de atención.
- Permitir al personal dispensador cerrar la entrega (total, parcial o pendiente) con trazabilidad del estado.
- Proteger los datos de salud y asegurar una experiencia usable y accesible para población diversa.
- Evaluar el prototipo con escenarios de uso y métricas definidas por el equipo, comparándolo con la línea base del proceso presencial.

El resultado no promete eliminar todos los problemas estructurales de abastecimiento o autorización; sí propone evitar que el paciente descubra esos problemas después de horas de espera.